

GUIDA PRATICA PER LA PREVENZIONE DELL'OBESITA' IN ETA' PEDIATRICA

Ospedale Meyer Firenze

DEFINIZIONE E STRUMENTI DIAGNOSTICI

La Societa' Italiana di Pediatria (SIP) ha definito l'obesita' una vera e propria malattia cronica a eziologia multifattoriale, caratterizzata dall'interazione tra fattori genetici e ambientali. La presenza di un variabile grado di eccesso ponderale rappresenta un frequente e importante problema che interessa una grande percentuale della popolazione pediatrica. In questi bambini e adolescenti, l'importanza di un'alimentazione equilibrata e sana e la necessita' di un corretto stile di vita che preveda adeguati livelli di attivita' ludico-motoria e fisica devono essere considerati un indispensabile viatico per il mantenimento del peso corporeo o per permettere una sua riduzione. Ciascuno di tali fattori, da solo, non e' in grado di contrastare efficacemente questo fenomeno.

In eta' evolutiva, la massa grassa aumenta in valori assoluti con l'eta' e nel tempo si modifica anche il suo rapporto con peso e altezza, anche se in maniera differente a seconda dei due sessi, rendendo piu' complessa una diagnosi di eccesso ponderale. Per definire sovrappeso e obesita' in eta' evolutiva e' impossibile utilizzare dei valori standard. Per questo, nella pratica clinica, e' necessario fare riferimento alle curve dei centili dell'Indice di Massa Corporea (BMI).

Il BMI si calcola dividendo il peso in kg per la statura in metri elevata al quadrato. Il valore ottenuto viene inserito in appositi grafici, le curve dei centili:

- Se il valore del BMI si colloca al di sopra del 95° centile ci troviamo in una situazione di obesita'.
- Se si colloca tra l'85° e il 95° centile ci troviamo in una situazione di sovrappeso.

Tali curve permettono di monitorare la crescita staturo-ponderale del bambino permettendo di intervenire prima che il fenomeno sia conclamato. Le diagnosi di sovrappeso e obesita' non possono essere soggettive.

COMPLICANZE DELL'OBESITA' INFANTILE

La letteratura scientifica delinea l'obesita' infantile come un fenomeno in grado di comportare numerose problematiche future, a medio e lungo termine. La maggior parte delle complicanze non si manifesta con esordio acuto ma tende a insorgere lentamente nel tempo. Risulta fondamentale riconoscere nel fattore tempo il principale determinante nel combatterle, dando alla prevenzione il ruolo chiave nella gestione del problema.

Complicanze metaboliche:

L'obesita' determina una ridotta risposta dei tessuti all'azione dell'insulina, condizione nota come insulino-resistenza. Comporta un innalzamento dei livelli di insulina nel sangue (iperinsulinemia) con importanti conseguenze sul metabolismo dei carboidrati e, se mantenuta nel tempo, puo' condurre alla sindrome metabolica, caratterizzata da ipertensione arteriosa, dislipidemia e ridotta tolleranza glucidica, correlata a un aumentato rischio di diabete mellito tipo 2 e malattia cardiovascolare.

Complicanze endocrine:

L'eccesso ponderale ha effetti sulla crescita: i bambini obesi sono spesso piu' alti dei loro coetanei anche se la statura adulta non e' maggiore di quella attesa. Puo' presentarsi puberta' anticipata, soprattutto nel sesso femminile. Nelle femmine con eccesso ponderale si puo' configurare il quadro clinico dell'ovaio policistico, con aumento della peluria, irregolarita' mestruali, acne e acanthosis nigricans.

Complicanze respiratorie:

La presenza di tessuto adiposo in eccesso puo' rendere meno elastica la gabbia toracica con conseguente difficolta' negli atti respiratori. Le apnee del sonno sono piu' diffuse nel bambino obeso. Si registra inoltre un aumento dell'asma nel bambino obeso soprattutto a partire dai 10 anni di eta'.

Complicanze muscolo-scheletriche:

L'aumento del carico di peso su strutture cartilaginee non ancora saldate puo' determinare ginocchio valgo, iperlordosi del tratto lombare della colonna, piede piatto e asimmetrie delle anche con atteggiamento scoliotico.

Complicanze psicosociali:

I bambini obesi sono frequentemente esclusi dalle attività motorie competitive, subiscono un considerevole stress psicologico e sono visti dalla società come goffi e impacciati. Ciò può minare l'autostima e condurre alla costruzione di un'immagine corporea negativa. Esiste una correlazione tra obesità e bullismo: i ragazzi obesi tra gli 11 e i 16 anni sono più frequentemente vittime di bullismo verbale e fisico.

Una perdita di peso sostanziale determina un miglioramento di tutte queste comorbidità.

Elenco completo delle complicanze:

- Neurologiche: pseudotumor cerebri
- Psicosociali: depressione, scarsa autostima
- Polmonari: apnee del sonno, intolleranza all'esercizio fisico, broncospasmo
- Endocrine: diabete tipo 2, pubertà precoce, ipogonadismo nei maschi, sindrome dell'ovaio policistico nelle femmine
- Cardiovascolari: ipertensione, coagulopatia, dislipidemia, infiammazione cronica
- Renali: glomerulosclerosi
- Gastrointestinali: calcoli biliari, steatoepatite
- Muscolo-scheletriche: epifisiolisi femorale, malattia di Blount, fratture, piede piatto

PREVENZIONE: I PRIMI 1000 GIORNI

La prevenzione inizia dal concepimento. L'alimentazione in gravidanza e nei primi anni di vita esercita un ruolo importantissimo nel condizionare uno sviluppo armonico del bambino, dal punto di vista del contenimento della generazione delle cellule adipose e dello sviluppo del sistema immunitario.

I bambini nutriti nei primi mille giorni di vita con una dieta che preveda proteine in eccesso, in particolare di origine animale, presentano modificazioni epigenetiche in grado di predisporli a sviluppare obesità e patologie metaboliche. Un'alimentazione errata o problematica metabolico-endocrinologiche durante la gravidanza o i primi 2 anni di vita possono

influenzare lo stimolo all'iperplasia della cellula adipocitaria e favorire l'attivazione di meccanismi epigenetici responsabili dell'aumento del peso.

L'alimentazione dei primi 1000 giorni puo' avere effetti a lungo termine: uno stimolo positivo o negativo in questo periodo puo' influenzare, anche in modo permanente, la salute futura.

Allattamento al seno materno:

Il latte materno e' specifico per il lattante, per la sua eta' reale e gestazionale, ed e' in grado di:

- Fornire i nutrienti necessari fino a sei mesi, essendo ricco di sostanze immunologicamente attive.
- Prevenire malattie nel presente (diarrea, otiti, infezioni respiratorie e urinarie) e nel futuro (obesita', diabete, malattie infiammatorie intestinali).
- Favorire lo sviluppo psicologico del bambino attraverso lo scambio di affetto con la madre.

E' bene iniziare gia' in sala parto, non stabilire un orario rigido per le poppate e non fare inutili doppie pesate. Nel caso in cui non sia possibile l'allattamento materno, si ricorrera' alle formule artificiali, che sono un'alternativa nutrizionalmente adeguata. L'allattamento materno sara' esclusivo fino al sesto mese e continuato almeno fino all'anno.

Alimentazione complementare (divezzamento):

Al sesto mese il solo latte non e' piu' sufficiente a coprire i fabbisogni nutrizionali, soprattutto del ferro. E' necessario introdurre altri alimenti. Questo passaggio va condotto con attenzione per evitare l'eccesso proteico, che correla con un aumentato rischio di obesita'.

E' importante non forzare il bambino che rifiuta le prime pappe: in questo caso si aspetteranno alcuni giorni per poi riproporle. Un'attenzione particolare va data alla consistenza dei cibi per evitare rischi di soffocamento: finche' il bambino non avra' la capacita' di masticare e' bene somministrare gli alimenti ben cotti e finemente tritati.

In questa fase si forma il gusto che condizionera' le scelte alimentari future. Indicazioni fondamentali:

- Evitare di salare i cibi.
- Non eccedere con alimenti contenenti zuccheri semplici.

- Evitare le bevande zuccherate.
- Sospendere l'uso del biberon entro i 12-24 mesi: dopo i 12 mesi il rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni mese di uso del biberon, che non favorisce una corretta regolazione del senso di sazietà.
- Instaurare corrette abitudini come la regolare suddivisione dei pasti nella giornata.

ALIMENTAZIONE IN ETA' PEDIATRICA

I Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) forniscono indicazioni pratiche per il soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale del bambino.

Per garantire un adeguato accrescimento, l'alimentazione del bambino deve essere:

- VARIA: offrire la variabilità senza costrizioni consente di assumere tutti i nutrienti. La monotonia è nemica della salute.
- MODERATA: mangiare in modo sano implica non solo la qualità e la varietà degli alimenti, ma anche la frequenza di consumo e la loro quantità, che aumenta col crescere dell'età.
- COMPLETA ed EQUILIBRATA: non esistono un alimento completo né cibi buoni e cibi cattivi. Assumere prodotti appartenenti a tutti i diversi gruppi alimentari in giuste quantità, alternandoli nell'arco della giornata, rende un pasto completo e i nutrienti facilmente assimilabili.

Le porzioni dei bambini sono diverse rispetto a quelle di un adulto. Per preparare una porzione giusta è utile usare una bilancia per dosare gli alimenti. Dopo aver impiattato, evitare di portare in tavola pentole con gli avanzi che possono invogliare a eventuali bis.

Distribuzione delle calorie giornaliere:

- Colazione: 20%
- Spuntino a metà mattina e merenda pomeridiana: 10%
- Pranzo: 40%
- Cena: 30%

L'alimentazione giornaliera va suddivisa in 4-5 pasti.

Colazione:

La prima colazione e' un pasto irrinunciabile: mette in moto il corpo e serve per avere una marcia in piu'. Per essere ricca ed energetica deve comprendere: latte o yogurt + pane o fette biscottate o biscotti o cereali + frutta fresca. Consigli pratici: consumare una cena leggera la sera e svegliarsi dieci minuti prima in modo da avere il tempo di sedersi a tavola con tranquillita'.

Spuntini:

Gli spuntini rappresentano una piacevole pausa spezza-fame per non arrivare troppo affamati all'ora di pranzo o cena. Devono essere semplici, gustosi, genuini. Lo spuntino a meta' mattina deve essere leggero mentre la merenda del pomeriggio deve essere piu' o meno abbondante a seconda dell'attivita' fisica svolta.

- Mattino: un frutto, un vasetto di yogurt, un pacchetto di crackers o grissini, qualche tarallino.
- Pomeriggio: una fetta di pane con marmellata o con olio e pomodoro, un pezzetto di focaccia senza farciture, una pizzetta piccola.

Pranzo:

Il pranzo costituisce il pasto quantitativamente piu' importante e deve essere piu' ricco e sostanzioso della cena. Un pasto completo con porzioni adeguate all'eta' prevede: pasta o altri cereali + secondo piatto + verdura cruda o cotta + frutta, oppure piatto unico + verdura + frutta.

Cena:

La cena e' il momento in cui la famiglia si riunisce. I piatti devono essere leggeri, composti da una quota adeguata di carboidrati associati a proteine. Un pasto completo puo' prevedere: minestra in brodo o passato di verdura + secondo piatto + verdura + pane + frutta. Arricchire la cena di verdure, magari sgranocchiate anche prima del pasto se il bambino e' affamato, creando forme curiose nel piatto per rendere il pasto piu' divertente.

TUTTI A TAVOLA INSIEME

I bambini imparano soprattutto osservando: il comportamento alimentare dei genitori e' un modello da imitare e una guida per la vita futura.

Prima di arrivare a tavola:

- Incoraggiare i bambini a sperimentare nuovi cibi e nuovi sapori in base alla stagionalita'.
- Organizzare attivita' ludiche per far loro conoscere il mondo dei vegetali, come fare un orto o andare insieme al mercato ortofrutticolo.
- Coinvolgerli nella preparazione o presentazione di alcuni piatti semplici, sfruttando la loro fantasia e curiosita'.

A tavola:

- Mangiare insieme in un clima sereno, con il televisore spento, conversando.
- Mangiare con gusto, senza fretta.
- Ritagliarsi uno spazio ben preciso per mangiare e stare seduti.
- A tavola tutti mangiano le stesse cose ma in quantita' diverse: a uguale qualita' corrisponde diversa quantita'.

Il cibo non dovrebbe mai essere utilizzato come premio o punizione per comportamenti piu' o meno desiderabili, altrimenti vi e' il rischio di caricare determinati alimenti con significati inadeguati.

EMOZIONI A TAVOLA

I bambini apprendono i comportamenti alimentari attraverso l'osservazione, la condivisione e l'imitazione degli altri, in particolare dei propri genitori. Ogni bambino ha caratteristiche diverse dagli altri e tale diversita' e' visibile anche nel funzionamento alimentare.

Quando l'alimentazione diventa il terreno in cui si giocano le relazioni familiari, la sua centralita' appare manifesta nella forma del corpo del bambino. Puo' accadere che il bambino non sappia cosa prova, non sia in grado di capirlo e spiegarlo, o non trovi il coraggio di parlarne e abbia trovato nel cibo la modalita' per comunicare il proprio disagio agli adulti.

La fame emotiva e' un'emozione travestita da fame e spesso parte da un desiderio improvviso di qualcosa che riempia un vuoto. Puo' attivarsi in qualunque momento della giornata, perfino a brevissima distanza da un pasto sostanzioso. Al contrario, la fame fisiologica si associa a sensazioni fisiche ben precise nella zona dello stomaco e appare con gradualita' agli orari dei pasti tipici della famiglia.

La condizione di obesita' di un bambino non e' mai un problema esclusivo del bambino, ma riguarda tutta la famiglia e le relazioni al suo interno. L'iperalimentazione, quando non e' legata a disfunzioni organiche o condizioni sindromiche, e' portatrice di un messaggio emotivo in cui un bisogno non e' riconosciuto.

I bisogni fondamentali del bambino:

- REGOLE: poche, chiare e adattabili all'eta', definiscono una cornice che crea senso di sicurezza e protezione.
- ATTENZIONE ALL'ALTRO: capacita' di notare e riflettere sui comportamenti che si discostano dal solito, come una maggiore irritabilita', chiusura o richiesta di cibo.
- DISPONIBILITA' EMOTIVA: interessarsi alle emozioni del bambino in modo rispettoso, condividere cio' che si e' notato di diverso, porre domande semplici e mai accusatorie, lasciare spazio al bambino per aprirsi o meno.

Garantire attenzione ai bisogni di sicurezza, amore e rispetto dell'individualita' favorisce l'emergere di tutti gli altri bisogni che possono nascondersi dietro la fame emotiva.